Клинические рекомендации

Корь

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B05.9** — Корь без осложнений
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 06.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/563_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Физикальное обследование 4

3.3 Лабораторные исследования 4

3.4 Специфическая диагностика 4

3.5 Инструментальные исследования и консультации 4

4. Лечение 5

4.1 Консервативное лечение 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Профилактика 5

5.2 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Корь — острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи: лихорадка, интоксикация, поражение дыхательных путей и конъюнктив, пятнисто-папулёзная экзантема с переходом в пигментацию.
- Патогномоничный симптом катарального периода — пятна Бельского — Филатова — Коплика: беловато-серые точки с венчиком гиперемии на слизистой оболочке щёк напротив коренных зубов, появляются **за 1–2 дня до сыпи**. Сыпь появляется **на 4–5-й день** этапно: за ушами и на лице, затем туловище, затем конечности.
- Диагноз подтверждается ПЦР мазка из носоглотки (оптимально **в первые 3–5 суток**) и IgM к вирусу кори в ИФА.
- Частые осложнения — пневмония, острый средний отит, синусит. Антибактериальные препараты для профилактики бактериальной суперинфекции не применяются.
- Госпитализация — в мельцеровский бокс инфекционного стационара при тяжёлом или осложнённом течении и по эпидемиологическим показаниям; выписка — **не ранее 5-го дня** от начала высыпания.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Корь — острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём.

Характерные проявления

1. лихорадка и симптомы интоксикации;
2. поражение дыхательных путей и конъюнктив;
3. пятнисто-папулёзная экзантема с переходом в пигментацию.

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология

Возбудитель — РНК-содержащий вирус кори (Measles morbillivirus) семейства Paramyxoviridae. Вирус нестоек: во внешней среде сохраняется не более 30 минут, но распространяется с потоком воздуха на значительные расстояния. Входные ворота — слизистая оболочка верхних дыхательных путей и конъюнктива. Вирус обладает выраженным иммуносупрессивным действием (анергия), что ведёт к вторичному инфицированию и осложнениям.

Эпидемиология

1. индекс контагиозности 95–98%;
2. инкубационный период **9–21 день**;
3. больной заразен в последние дни инкубации, в продромальном периоде и **первые 4 суток** высыпания; **с 5-х суток** от появления сыпи незаразен;
4. заражение возможно и без непосредственного контакта, в том числе по вентиляционным каналам; после болезни — стойкий пожизненный иммунитет.

В 2022 г. в России зарегистрировано 102 случая кори (0,07 на 100 тыс.), 82,4% заболевших не привиты или прививочный анамнез неизвестен; в 2023 г. заболеваемость резко выросла.

2.3 Классификация

1. **по типу** — типичная; атипичная — митигированная, абортивная, стёртая, бессимптомная
2. **по тяжести** — лёгкая, средней тяжести, тяжёлая
3. **по течению** — гладкое; негладкое — с осложнениями, наслоением вторичной инфекции, обострением хронических заболеваний

2.4 Клиническая картина

Периоды типичной кори

1. **инкубационный** — **9–21 день**
2. **катаральный** — **3–4 дня**: температура 38–40 °C, ринит, фарингит, конъюнктивит, светобоязнь, интоксикация; нарастают катаральные явления, развивается ларинготрахеит; пятна Бельского — Филатова — Коплика **за 1–2 дня до сыпи**
3. **высыпания** — **с 4–5-го дня**, этапно: 1-е сутки — за ушами, переносица, лицо, шея, верх груди и плечи; 2-е — туловище; 3–4-е — дистальные отделы рук и ноги; сыпь пятнисто-папулёзная, сливная, ярко-красная
4. **пигментации** — **с 3–4-го дня** сыпи, этапно; длится **7–14 дней**, возможно отрубевидное шелушение

1. **митигированная** — после введения иммуноглобулинов, плазмы, крови в инкубационном периоде: периоды укорочены, симптомы стёрты
2. **абортивная** — типичное начало, **через 1–2 дня** симптомы исчезают, сыпь — на лице и туловище
3. **стёртая и бессимптомная** — слабые быстропроходящие симптомы или их отсутствие; выявляются, как правило, в очагах при обследовании контактных
4. **дети первого полугодия** — короткий слабый катаральный период, пятна Коплика могут отсутствовать, высыпание **до 2 дней**; быстро развиваются пневмония, отит, энцефалит
5. **привитые** — как правило, более лёгкое течение

Коревая анергия сохраняется **до 1 месяца** и служит фактором риска наслоения вирусно-бактериальных инфекций.

Осложнения возникают на любом этапе: первичные (коревые) и вторичные (бактериальные), ранние и поздние (в периоде пигментации).

1. пневмония — одно из наиболее частых осложнений;
2. острый средний отит, синусит;
3. кератоконъюнктивит, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта;
4. коревой энцефалит (менингоэнцефалит) — **на 4–5-й день** после появления сыпи или позже, тяжёлое течение и высокий риск летального исхода.

Степени тяжести

Признак	Лёгкая	Средней тяжести	Тяжёлая
Лихорадка	**до 38,5 °C**, 1–5 дней	**более 38,5 °C**, 6–7 дней	**более 39,5 °C**, более 7 дней
Катаральный синдром	лёгкий	ярко выражен	ярко выражен более 7 дней
Экзантема	неяркая, необильная, бледная пигментация	обильная, яркая, склонная к слиянию	обильная, сливная, геморрагический синдром

Дифференциальный диагноз

1. краснуха, скарлатина;
2. аденовирусная, энтеровирусная, парвовирусная B19 и герпесвирусная HHV-6 инфекции;
3. инфекционный мононуклеоз;
4. токсикоаллергическая сыпь.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. **подозрительный случай** — острое заболевание с одним или несколькими типичными признаками кори
2. **вероятный случай** — клинические признаки и эпидемиологическая связь с подозрительным или подтверждённым случаем
3. **подтверждённый случай** — подозрительный или вероятный случай после лабораторного подтверждения

Окончательный диагноз устанавливается по клиническим данным при лабораторном подтверждении. В эпиданамнезе уточняют контакт с больным, пребывание в очаге, вакцинацию, введение иммуноглобулина.

3.2 Физикальное обследование

Оценивают

1. кожу и слизистые оболочки: сыпь, пятна Бельского — Филатова — Коплика, конъюнктивит;
2. температуру: при типичной форме 38–39 °C с первых дней, снижение на 2–3-й день, вторая волна **на 4–5-е сутки** вместе с сыпью;
3. лёгкие: в первые 3–4 суток возможны вирусные поражения, **с 5-х суток** — преимущественно бактериальные;
4. менингеальные и очаговые симптомы; сердце; живот (стоматит, энтерит, энтероколит).

3.3 Лабораторные исследования

Общий анализ крови — всем

1. **неосложнённая корь** — лейкопения, нейтропения, эозинопения, относительный лимфоцитоз, СОЭ не изменена
2. **бактериальные осложнения (пневмония, синусит)** — нарастают лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, СОЭ

1. **общий анализ мочи** — всем
2. **биохимический анализ крови** — при среднетяжёлом и тяжёлом течении; с 4-го по 8-й день возможен цитолиз (АЛТ, АСТ)
3. **СРБ и прокальцитонин** — при тяжёлом и осложнённом течении, подозрении на бактериальную инфекцию

3.4 Специфическая диагностика

ПЦР с обратной транскрипцией на РНК вируса кори в мазке из носоглотки — наиболее эффективный метод: РНК определяется ещё в инкубационном периоде, **за 3–5 дней** до сыпи.

1. больные: **3–5 суток** после манифестации или первый день госпитализации;
2. контактные: **через 5–7 дней** после контакта;
3. новорождённые от матерей, переболевших корью в конце беременности: только ПЦР (материнские антитела делают ИФА неинформативным).

IgM к вирусу кори в ИФА подтверждают диагноз; IgG определяют двукратно: 1-я сыворотка **на 4–5-й день** сыпи, 2-я — **не ранее чем через 10–14 дней**. Нарастание титра IgG **в 4 раза и более** в парных сыворотках служит основанием для диагноза.

3.5 Инструментальные исследования и консультации

1. **ЭКГ** — при подозрении на поражение сердца, при среднетяжёлой и тяжёлой кори, заболеваниях сердца
2. **рентгенография лёгких** — во всех случаях подозрения на пневмонию; при отрицательном результате — КТ (вирусная пневмония интерстициальная)

Консультации специалистов

1. **оториноларинголог** — при подозрении на отит или синусит
2. **невролог** — при тяжёлой кори и неврологических симптомах
3. **анестезиолог-реаниматолог** — при неотложных состояниях — решение о переводе в ОРИТ

4. Лечение

4.1 Консервативное лечение

Специфическое лечение кори не разработано. Постельный режим соблюдают весь период лихорадки и **2 суток** после нормализации температуры: его несоблюдение увеличивает риск осложнений. Объём жидкости — физиологическая потребность с учётом патологических потерь.

Этиопатогенетически применяют #интерферон альфа-2b; наиболее эффективен **в первые 3 суток** болезни.

1. дети до 7 лет: 150 000–500 000 МЕ;
2. дети 7–12 лет: 500 000–100 000 МЕ (так в тексте КР, см. «Неточности»);
3. старше 12 лет и взрослые: 1 000 000 МЕ;
4. кратность и длительность: 2 раза в сутки с интервалом 12 часов, 5–10 дней.

Для снижения температуры у детей применяют парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки) внутрь или ректально; есть форма парацетамола для внутривенного введения.

При среднетяжёлой и тяжёлой кори проводят инфузионную терапию растворами электролитов для дезинтоксикации и коррекции водно-электролитного баланса, исходя из потребности, потерь и дефицита жидкости.

Противомикробные препараты системного действия для предотвращения бактериальной суперинфекции не рекомендуются: при неосложнённой вирусной инфекции они не предотвращают суперинфекцию, а способствуют ей, подавляя нормальную флору.

Применяют местные средства (полоскания, тёплое питьё, ингаляции, таблетки и пастилки для рассасывания), физиотерапию и симптоматическую терапию; осложнения лечат по рекомендациям соответствующих нозологий.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Непривитым детям (не достигшим прививочного возраста, с противопоказаниями или отказом) иммуноглобулин человека нормальный вводят **не позднее 5-го календарного дня** с момента контакта.

Плановая вакцинация по национальному календарю

1. вакцинация: **в 12 месяцев**;
2. ревакцинация: **в 6 лет**.

Детей от серонегативных матерей прививают **в 8 месяцев** моновакциной, затем в 14–15 месяцев и в 6 лет.

Непривитые взрослые 18–35 лет прививаются двукратно с интервалом **не менее 3 месяцев**; однократно привитые более 3 месяцев назад получают одну дозу.

Охват вакцинацией и ревакцинацией детей в декретированных возрастах должен составлять не менее 95%, взрослых 18–35 лет и декретированных профессий 18–55 лет — не менее 90%.

Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится **в первые 72 часа** с момента выявления больного, при расширении очага — **до 7 дней**.

Кому

1. контактным без ограничения возраста, не болевшим, не привитым и без сведений о прививках;
2. однократно привитым **старше 6 лет**.

Детям **до 8 месяцев** и лицам с противопоказаниями к живым вакцинам после контакта вводят иммуноглобулин.

5.2 Показания к госпитализации

Госпитализация в инфекционный стационар

1. тяжёлое и (или) осложнённое течение;
2. тяжёлые хронические заболевания;
3. независимо от тяжести: пребывание в организациях с круглосуточным пребыванием, общежитиях, неблагоприятных бытовых условиях; декретированные контингенты в семье.

Больных размещают в мельцеровских боксах; детей — в стационарах с отделением реанимации. В ОРИТ госпитализируют при тяжёлых и осложнённых формах с выраженной интоксикацией, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, церебральными нарушениями.

Критерии выписки

1. удовлетворительное состояние;
2. **не ранее 5-го дня** после начала высыпания.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Корь»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 06.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	563_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза #интерферона альфа-2b детям 7–12 лет указана как «500000–100000 МЕ» (нижняя граница больше верхней); по смыслу ряда доз — 500 000–1 000 000 МЕ.
- Жаропонижающие у детей названы «нестероидными противовоспалительными средствами… только на основе парацетамола или ибупрофена»; парацетамол к НПВП не относится.